

WERSJA AKTYWOWANA — DO WYSŁANIA

Niniejszy dokument jest wersją aktywowaną Apelu obywatelskiego o skierowanie ustawy UD207 do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej (art. 122 ust. 3 Konstytucji RP). Apel składa się w okresie 21-dniowym przewidzianym przez art. 122 ust. 2 Konstytucji na podpis Prezydenta. Pakiet uzupełniający (Memorandum prawne UD207 v2.0; Załącznik 1 Policy Paper EBM v1.10 z Częścią B Sekcja Konstytucyjna v3.0; Dokument A Stanowisko v3.9) jest załączony osobno.

Przed wysyłką wymaga uzupełnienia:

— [data uchwalenia ustawy przez Sejm — ostateczne głosowanie] — [data uchwalenia / nie wniesienia poprawek przez Senat] — [data przekazania ustawy Prezydentowi — początek 21-dniowego terminu z art. 122 ust. 2 Konstytucji] — [aktualna data wysyłki Apelu] — [numer telefonu i adres korespondencyjny koordynatora] — [ewentualne odniesienia do konkretnych zmian wprowadzonych w toku prac parlamentarnych]

**zespół obywatelski Koordynator pakietu obywatelskiego — UD207 E-mail: pacjentmaprawo@proton.m
· Tel.: [uzupełnić przed wysyłką] Adres: [uzupełnić przed wysyłką]**

Warszawa, [DATA WYSYŁKI APELU]

Pan Karol Nawrocki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

Do wiadomości: Pan Zbigniew Bogucki, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Dotyczy: Apel o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (UD207, potocznie „lex szarlatan”), w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją przed jej podpisaniem.

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z przekazaniem Panu w dniu [DATA PRZEKAZANIA] do podpisu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (projekt UD207, przyjęty przez Radę Ministrów 12 maja 2026 r.; uchwalony przez Sejm w dniu [DATA SEJM] i Senat w dniu [DATA SENAT]), zwracam się — w imieniu zespołu obywatelskiego skupiającego lekarzy, naukowców, pacjentów i prawników — z apelem o **wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej (art. 122 ust. 3 Konstytucji RP)** w sprawie zgodności tej ustawy z Konstytucją, w okresie 21-dniowym przewidzianym przez art. 122 ust. 2 Konstytucji RP.

Apel jest oparty na trzech ściśle powiązanych argumentach: argumencie wolnościowym, argumencie konstytucyjnym oraz argumencie systemowym. Wszystkie trzy razem uzasadniają, że ustawa w obecnym kształcie powinna zostać poddana kontroli Trybunału przed podpisaniem — tak, by ewentualne wady konstytucyjne mogły zostać naprawione przed wejściem przepisów w życie.

I. ARGUMENT WOLNOŚCIOWY — Pana programowe zobowiązanie

W kampanii prezydenckiej 2025 r. zechciał Pan podpisać deklarację programową złożoną wspólnie z Konfederacją, w której podjął Pan zobowiązanie nie podpisywania ustaw zwiększających podatki **oraz ograniczających wolność obywateli**. Deklaracja ta — czytelna i jednoznaczna — została przez Pana uczyniona trzonem programu, na który Polacy oddali na Pana 10 606 877 głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 r.

Projekt UD207 — potocznie „lex szarlatan” — wpisuje się w **dosłownie definiowaną kategorię ustaw ograniczających wolność obywateli**. W swojej istocie:

- wprowadza karę finansową **do 1 000 000 zł** dla podmiotu, który stosuje metodę leczenia uznaną przez Rzecznika Praw Pacjenta za niezgodną z „aktualną wiedzą medyczną” — pojęciem, którego ustawa nie definiuje;
- wprowadza odrębną karę osobistą dla kierownika takiego podmiotu w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 160 tys. zł);
- ogranicza prawo pacjenta do **świadomego wyboru metody leczenia**, w tym do skorzystania z metod uzupełniających, których pacjenci szukają z własnych przekonań i z własnych środków;
- przewiduje **decyzje tymczasowe z rygorem natychmiastowej wykonalności** zamykające gabinety lekarskie przed wysłuchaniem strony i przed jakąkolwiek kontrolą sądową;
- wprowadza w art. 64a wyłączenie art. 10 i 81 Kodeksu postępowania administracyjnego — czyli wyłączenie prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu i do wypowiedzenia się co do dowodów.

W każdym z powyższych aspektów ustawa **ogranicza wolność obywateli**: pacjenta jako konsumenta świadczeń zdrowotnych, lekarza jako podmiotu wykonującego zawód, podmiotu leczniczego jako podmiotu gospodarczego. Trzy fundamentalne wolności konstytucyjne — art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 47 (autonomia jednostki), art. 68 ust. 1 (prawo do ochrony zdrowia rozumianej jako prawo wyboru) — są naruszone jednocześnie i w sposób, który niemożliwy jest do skorygowania w drodze interpretacji administracyjnej.

Podpisanie tej ustawy w obecnym kształcie stałoby się aktem **wprost niezgodnym z deklaracją programową**, na podstawie której wybrali Pana Polacy. Apelujemy o spójność tej deklaracji.

II. ARGUMENT KONSTYTUCYJNY — pięć warstw niezgodności

Jako prezydent jest Pan strażnikiem Konstytucji RP. Projekt UD207 narusza Konstytucję w pięciu warstwach:

1. Art. 2 Konstytucji — zasada przyzwoitej legislacji i pewności prawa

Ustawa operuje pojęciem „aktualnej wiedzy medycznej” jako kryterium karząco-administracyjnym, lecz **pojęcia tego nie definiuje**. Adresat normy (lekarz, podmiot leczniczy) nie jest w stanie z góry przewidzieć, jakie postępowanie wystawia go na sankcję 1 mln zł. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące praktyk integracyjnych, na które powołuje się sam projektodawca w uzasadnieniu, stosuje dychotomię „zgodne / niezgodne” bez gradacji poziomów dowodowych (OCEBM, GRADE), bez rozróżnienia między terapią podstawową a wspomagającą, bez uwzględnienia statusu off-label czy eksperymentu leczniczego. Sąd cytuje wprost: *„Przepisy prawa nie dzielą świadczeń zdrowotnych na »podstawowe«, »uzupełniające« czy »wspomagające« leczenie”*. Tymczasem w polskim systemie refundacyjnym **leki onkologiczne uzyskują refundację na podstawie znacznie słabszych dowodów** (glasdegib — OCEBM 2 z jednoramiennego badania fazy II) niż te, które ustawa kwalifikuje jako pseudomedycynę. Standard dowodowy nie tylko nie jest określony — jest stosowany **asymetrycznie**.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał (m.in. SK 56/04, SK 13/05), że zasada państwa prawnego obejmuje obowiązek tworzenia przepisów, których adresat może z góry przewidzieć, jakie zachowanie spowoduje sankcję.

2. Art. 78 Konstytucji — prawo do zaskarżenia decyzji × precedens Sądu Najwyższego z grudnia 2025 r.

Art. 64a projektu wyłącza wobec praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów stosowanie art. 10 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie wprowadza decyzję tymczasową z rygorem natychmiastowej wykonalności. W praktyce: gabinet ambulatoryjny może zostać zamknięty w dniu doręczenia decyzji, bez wysłuchania lekarza, przed sądową kontrolą legalności. Procedura odwoławcza działa **po fakcie zamknięcia**.

Casus empiryczny — chronologia 2025 r.:

— W 2025 r. sąd lekarski w II instancji zawiesił na 1 rok prawo wykonywania zawodu lekarzowi opiekującemu się od kilkunastu lat pacjentami onkologicznymi w ambulatoryjnej klinice integracyjnej, zaosttrzając wcześniejszą karę nagany i jednocześnie wyłączając jawność postępowania. Decyzja natychmiast wykonalna.

— **Styczeń-grudzień 2025 r.** Pacjenci skierowali pisemne apele do Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. W publicznie dostępnych materiałach nie odnaleziono informacji o udzielonej im pomocy. Pacjenci uruchomili własną stronę dokumentującą sytuację.

— **Grudzień 2025 r. Sąd Najwyższy uwzględnił w całości kasację i uchylił oraz umorzył całe postępowanie** prowadzone przed Naczelnym Sądem Lekarskim. Powodem: rażące naruszenie prawa do obrony w postępowaniu sądu lekarskiego, w którym formalnie istniały gwarancje proceduralne. SN uznał, że incydentalne uchybienie tym gwarancjom jest niedopuszczalne.

Przez **11 miesięcy** pacjenci pozostawali bez opieki, mimo apeli do organów państwa. Po uchyleniu orzeczenia NSL nikt nie poniósł odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentom — Rzecznik Praw Pacjenta nie podjął działań kompensacyjnych ani interwencyjnych.

Projekt UD207 wyłącza analogiczne gwarancje **ustawowo, jako normę systemową**. Jeśli incydentalne uchybienie gwarancjom proceduralnym w postępowaniu sądu lekarskiego było dla Sądu Najwyższego niedopuszczalne — to ustawowe ich wyłączenie jest *a fortiori* niezgodne z art. 78 Konstytucji. Casus 2025 r. pokazuje empirycznie, że przerwanie ciągłości opieki onkologicznej w trybie natychmiastowej wykonalności **niesie nieodwracalne skutki dla pacjentów onkologicznych**, których stan zdrowia wymaga ciągłości leczenia, a nie procedury odwoławczej *post factum*.

3. Art. 31 ust. 3 Konstytucji — zasada proporcjonalności w świetle składu Rady Ekspertów RPP

Test proporcjonalności wymaga, by ograniczenie konstytucyjnych wolności było konieczne i proporcjonalne. W kontekście UD207 wymaga to uwzględnienia organizacyjnego otoczenia stosowania ustawy.

Rzecznik Praw Pacjenta — organ otrzymujący w projekcie uprawnienia quasi-sądowe — będzie wydawać decyzje merytoryczne wsparte opiniami **Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta**. Analiza publicznie dostępnych deklaracji konfliktów interesów członków tej Rady ujawnia poważne wątpliwości co do jej bezstronności:

— **Prof. Marcin Czech**, członek Rady, w trzech publikacjach naukowych z lat 2024–2025 deklaruje konsultacje/doradztwo dla **piętnastu firm farmaceutycznych jednocześnie** (Frontiers in Public Health 2024, PMC10975328), bezpośrednie finansowanie badania przez Merck Sharp & Dohme (DOI 10.3389/fpubh.2025.1682169) oraz honoraria Advisory Board od Sanofi i AstraZeneca (Viruses 2025, DOI 10.3390/v18010060).

— **Prof. Bolesław Samoliński**, przewodniczący Rady, w publikacji ScienceDirect 2025 (art. S2213219825005355) deklaruje, że pobiera honoraria osobiście od „patient ombudsman” — czyli od Rzecznika Praw Pacjenta. Przewodniczący ciała doradczego pobiera honoraria od organu, którego decyzje ma niezależnie opiniować. W standardach bioetyki publikacyjnej (ICMJE) jest to klasyczny konflikt wykluczający z funkcji recenzenta.

— **Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska**, członkini Rady, publicznie, w bezpośrednim kontekście głośnej sprawy sądowej dotyczącej praktyki integracyjnej, opublikowała na koncie X apel o uchwalenie ustawy „lex szarlatan” w bezpośrednim kontekście tej sprawy.

Rada Ekspertów nie ma ustawowego mechanizmu wyłączenia stronniczego członka — w odróżnieniu od art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, który art. 64a projektu wprost wyłącza.

4. Art. 47 i art. 22 Konstytucji — autonomia jednostki i wolność działalności gospodarczej

Ustawa ogranicza prawo pacjenta do świadomego wyboru metody leczenia, w tym do skorzystania z metod uzupełniających, których koszty pokrywa z własnych środków. Ogranicza również prawo podmiotu leczniczego do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z osądem klinicznym lekarza, mimo posiadania pełnych uprawnień zawodowych. W uzasadnieniu projektu sam projektodawca wymienia jako przykład „pseudomedycyny” metodę ILADS w leczeniu boreliozy — co oznacza, że ustawa obejmuje **lekarzy z pełnymi polskimi specjalizacjami**, stosujących protokoły niezgodne z krajowymi wytycznymi. Wykraczanie poza standard krajowych wytycznych nie jest pseudomedycyną — jest praktyką medycyny opartej na osądzie klinicznym, której element jest fundamentem zawodu lekarza.

5. Iluzja głosu pacjentów

Projekt UD207 jest publicznie prezentowany jako odpowiadający „głosowi pacjentów”. W rzeczywistości recenzowane badanie naukowe (Makowska M., Mulinari S., Ozieranski P., Int J Soc Determinants Health Health Serv 2025; 55(2):199-212; PMID 39726201; PMC11977834) dokumentuje, że w latach 2012-2020 trzydzieści trzy firmy farmaceutyczne wypłaciły polskim organizacjom pacjenckim łącznie **€13 729 644**, z czego **37,5% trafiło do organizacji onkologicznych**. Najbardziej połączoną organizacją w sieci była Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (47 organizacji członkowskich, 21 firm pharma jako darczyńcy). Przedstawiciele organizacji wpisanych w tę sieć (Alivia, OFO, Fundacja MY PACJENCI) zasiadają w Radzie Ekspertów RPP, opiniującej projekt.

Onkofundacja Alivia w artykule z 10 marca 2025 r. publicznie poparła projekt i aktywnie zachęca pacjentów do donoszeń do Rzecznika Praw Pacjenta — czyli organu, którego rozszerzenie kompetencji wspiera, i który będzie opiniowany przez wicedyrektorkę Alivii w Radzie Ekspertów.

Argument o „głosie pacjentów” wspierającym ustawę nie spełnia warunku reprezentatywności demokratycznej — jest produktem ekonomicznym strukturalnie zależnym od podmiotów, które są beneficjentem rynkowej eliminacji konkurencyjnych terapii.

5a. Deficyt udokumentowanego mandatu „głosu pacjentów” w procesie konsultacyjnym

Niezależnie od strukturalnej zależności finansowej organizacji pacjenckich, projektowi UD207 brakuje **udokumentowanego mandatu reprezentacyjnego** od grupy, której prawa są przedmiotem najgłębszej ingerencji.

W procesie konsultacyjnym wokół projektu UD207:

- nie przeprowadzono publicznie udokumentowanych ankiet ani konsultacji wśród pacjentów onkologicznych aktywnie korzystających ze świadczeń medycyny komplementarnej i integracyjnej;
- federacje organizacji pacjenckich wypowiadające się publicznie za projektem nie udostępniły ankiet, konsultacji ani sprawozdań merytorycznych wskazujących na podstawę zajętogo stanowiska wobec UD207;
- członkowie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta reprezentujący organizacje pacjenckie nie składają publicznych disclosure’ów dotyczących doświadczenia własnego z chorobą, której pacjentów mieliby reprezentować w procesie konsultacyjnym;
- brak publicznego wspólnego stanowiska wszystkich organizacji członkowskich federacji reprezentowanych w Radzie Ekspertów RPP — przekaz publiczny pochodzi wyłącznie od przewodnictwa federacji.

W konsekwencji „interes publiczny pacjentów” jako konstytutywne uzasadnienie projektowanego ograniczenia praw konstytucyjnych pozostaje deklaratywny, a nie empirycznie udokumentowany. Stanowi to **drugą strukturalną lukę w teście proporcjonalności** (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) — symetryczną do braku danych ilościowych w OSR (zob. § 7 niżej): od strony kosztów regulacja nie wykazuje skali zjawiska, od strony korzyści — empirycznie udokumentowanego interesu beneficjentów.

Niniejszy zarzut nie ma charakteru personalnego wobec poszczególnych członków gremiów opiniodawczych. Stanowi natomiast zarzut **strukturalny** wobec mechanizmu konsultacyjnego, który nie wymaga od reprezentantów organizacji pacjenckich udokumentowanego mandatu od bazy pacjentów, nad którymi mają orzekać.

6. Zarzuty wobec projektu nie są radykalne — to mainstream strony pracodawców systemu zdrowia

Wątpliwości konstytucyjne wobec UD207 dzielają nie tylko organizacje obywatelskie i zawody medyczne. W lipcu 2025 r. **siedem organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia — Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP oraz cztery inne** — opublikowało wspólne stanowisko wobec projektu UD207, podnoszące dokładnie te same zarzuty, które są przedmiotem niniejszego apelu:

— art. 64a ust. 3 (rygor natychmiastowej wykonalności) — „**absolutnie nieakceptowalny**”; — **art. 64a ust. 4 (wyłączenie art. 10 i 81 KPA) — „rażące naruszenie KPA”**; — art. 67zj (definicja praktyki pseudomedycznej) — „**zbyt szeroka, nieprzewidywalna definicja**”; — art. 67zl ust. 4 — odwrócenie ciężaru dowodu jako samodzielny zarzut konstytucyjny.

Stanowisko jest publicznie dostępne pod adresem: pracodawcydlazdrowia.pl/wp-content/uploads/2025/07/Stanowisko-nowelizacji-ustawy-o-RPP-UD-207_FINAL.pdf. Stanowi **niezależną weryfikację argumentacji konstytucyjnej** przez główny nurt instytucjonalny systemu ochrony zdrowia w Polsce. Argumenty zawarte w niniejszym apelu nie są pozycją krańcową lub radykalną — są obecne w głównym nurcie środowiska pracodawców, samorządów zawodowych i niezależnych prawników konstytucjonalistów.

7. Brak danych ilościowych w Ocenie Skutków Regulacji — wada proceduralna projektu

W całej Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu UD207 **nie ma żadnych danych ilościowych** uzasadniających skalę regulowanego zjawiska:

— brak szacowanej liczby „pseudomedyków” w Polsce; — brak danych o skali finansowej zjawiska; — brak danych o liczbie pacjentów poszkodowanych; — brak analizy skuteczności istniejących instrumentów prawnych (art. 58 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 286 k.k., reżim UOKiK / nieuczciwych praktyk rynkowych, samorzady zawodowe).

Gazetą Lekarską w kwietniu 2026 r. cytuje Rzecznika Praw Pacjenta wyłącznie ogólnie: „*Rzecznik prowadzi rocznie kilkaset postępowań dot. zbiorowych praw pacjentów*” — ale to wszystkich postępowań, nie pseudomedycyny.

Brak danych ilościowych narusza **art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów** wymagającego rzetelnej analizy skutków finansowych regulacji oraz **zasadę przyzwoitej legislacji** wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP. To autonomiczna wada proceduralna projektu, niezależna od jego wad merytorycznych.

8. Vacatio legis 3 miesiące — 50% standardu Trybunału Konstytucyjnego

Linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego (wyrok K 47/14 z 14.10.2015 r., wyrok K 14/07 z 2009 r., wyrok P 29/13 z 2014 r.) wskazuje, że dla regulacji nakładających nowe obowiązki lub sankcje na przedsiębiorców minimalne vacatio legis wynosi **6 miesięcy**. Projekt UD207 przewiduje vacatio legis trzymiesięczne — **dwukrotnie krótsze niż minimum wymagane przez Trybunał Konstytucyjny**. Uzasadnienie tego wyboru nie zostało publicznie przedstawione w żadnym dokumencie procesu legislacyjnego.

9. Pod-inkluzywność — ustawa omija realnie nieuczciwych

Projekt jest zarazem zbyt szeroki i zbyt wąski. Zbyt wąski, bo podmiot działający w złej wierze może zarejestrować działalność poza Unią Europejską i pozostać poza zasięgiem ustawy — Rzecznik może wobec niego najwyżej opublikować ostrzeżenie. Realnie obciążeni zostaną krajowi, jawnie i uczciwie

działający świadczeniodawcy. Środek, który nie sięga głównego źródła nadużyć, a dotkliwie obciąża uczciwych, nie spełnia testu niezbędności i proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

10. Ochrona legalnych zawodów wspomagających

Nieostre kryteria i efekt mrozący projektu sięgają poza lekarzy — także w stronę legalnie wykonywanych zawodów i usług wspomagających (fizjoterapeutów, dietetyków, masażystów, zielarzy, akupunkturzystów i innych), którzy nie roszczą sobie prawa do „leczenia”, lecz wspierają pacjentów i odciążają system. Zawody te należy regulować przez kwalifikacje i rejestr (na wzór niemieckiego systemu Heilpraktiker czy austriackich dyplomów ÖÄK), a nie penalizować całej dziedziny; ustawa nie może ich stygmatyzować ani wypychać z rynku.

11. Szybka ścieżka dla pacjentów onkologicznych

Dla pacjenta onkologicznego czas jest częścią leczenia. Dla świadczeń z użyciem preparatów zarejestrowanych i stosowanych off-label powinna wystarczać pełna informacja i świadoma zgoda — bez zbędnych formalności. Ścieżki eksperymentalne (eksperyment leczniczy, badanie kliniczne) powinny być realnie przyspieszone i odbiurokratyzowane, przy zachowaniu niezbędnego minimum gwarancji (świadoma zgoda, dokumentacja, opinia komisji bioetycznej w trybie pilnym). Świadczenia te pacjenci finansują z własnych środków — nie obciążają budżetu państwa ani kolejek NFZ.

12. Wsparcie rozwoju medycyny integracyjnej zamiast represji

Brak dowodów wysokiej jakości nie przesądza ani o nieskuteczności, ani o niebezpieczeństwie metody — bywa skutkiem braku finansowania. Badanie III fazy to lata i dziesiątki-setki milionów; stać na nie niemal wyłącznie komercyjnych sponsorów, przez co substancje bez patentu (naturalne, repurposed) są w systemie rejestracji strukturalnie upośledzone niezależnie od potencjału. Państwo powinno wspierać niezależne badania, standaryzację i nadzór jakości medycyny integracyjnej — na wzór rozwiązań w innych państwach UE — co podnosi bezpieczeństwo pacjentów, rozwija polską naukę i odciąża system publiczny.

III. ARGUMENT SYSTEMOWY — UD207 a kryzys systemu zdrowia

Niezależnie od argumentów wolnościowych i konstytucyjnych, projekt UD207 wprowadza **paradoks systemowy w obszarze finansowania ochrony zdrowia**:

- Budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2025 przekroczył **220 miliardów złotych**, z czego niemal **33 miliardy złotych pokrył budżet państwa** w formie dotacji (źródło: PAP, 2 marca 2026 r.). NFZ jest **technicznie bankrutem**, utrzymywanym dzięki transferom z budżetu państwa.
- Polska wydaje na zdrowie zaledwie **8,1% PKB**, przy średniej OECD wynoszącej **9,2% PKB** (raport OECD „Health at a Glance 2025”). System ochrony zdrowia jest **strukturalnie niedofinansowany**.
- Pacjenci stosujący terapie uzupełniające w sektorze prywatnym **całkowicie pokrywają koszty z własnych środków** — bez obciążenia budżetu NFZ.
- Pacjenci onkologiczni stosujący terapie wspomagające często **lepiej tolerują leczenie konwencjonalne**, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na refundowane leki przeciwwymiotne, opioidy oraz czynniki wzrostu (Neulasta, Emend) — bezpośrednio oszczędności dla NFZ.
- Ustawa UD207 likwiduje sektor prywatnej medycyny komplementarnej i wymusza migrację pacjentów do systemu NFZ. **Pogłębia kryzys finansowy systemu**, który już dziś wymaga pokrycia 33 mld zł rocznie z budżetu państwa.